PROTOCOLLO 80

Trattamento della cefalea cervicogenica associata

Ridurre la cefalea originata dal rachide cervicale alto

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Cefalea cervicogenica e DTM	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Cefalea unilaterale che parte dal collo
- ✓ Rigidità C1–C2
- ✓ Dolore aggravato dai movimenti del collo

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Valutazione

Test flessione-rotazione e palpazione cervicale alta.

2



FASE 2

Terapia manuale

Mobilizzazione C0–C1 e C1–C2.

3



FASE 3

Esercizio

Flessori profondi e muscoli scapolari.

4



FASE 4

Educazione

Postura e gestione delle attività.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	6 a 8
Frequenza	2 a settimana
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Combinazione di terapia manuale ed esercizio
- ✓ Monitora frequenza e intensità della cefalea
- ✓ Diario della cefalea

Errori da evitare

- ! Trattare solo la mandibola
- ! Ignorare i segnali di allarme della cefalea
- ! Assenza di esercizio attivo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario della cefalea	Annotare frequenza, durata e intensità	ogni giorno

! **Nota clinica.** Cefalea con caratteristiche nuove o progressive richiede sempre una valutazione medica.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.